

ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ ИДЕЙ 2.0 · СЕМИНАР 25–27.08.2026

ДОКЛАД · 20 МИНУТ ЧТЕНИЯ · ОДИН ТЕЗИС НА РАЗДЕЛ

Не просто накормить

Как право выбора доходит до тарелки: безопасность, документы и пилот в домах социального обслуживания

Дискуссия «Организация питания: опыт реализации проектов» · 26.08.2026, 14:00–15:30

Площадка № 2 — ДСО «Тесовый берег» · модераторы: Чистяков Е. В., Нурбаев Т. А.

Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“» · версия 1.0 · сверка
22.08.2026

Кому: директору стационарной организации соцобслуживания (ПНИ/ДСО), который слышит тему впервые. **За сколько:** 20 минут; один тезис на раздел. **После:** понять границу безопасности, комплект документов и с чего начать пилот.

Самодостаточная версия. Полный референс — методическое руководство; материал на стол — «Материал к сессии 26.08». Числа и нормы сверены на 22.08.2026; источники — в тексте. Класс силы источника указан там, где утверждение может попасть в спор с проверяющим.

1. Рамка и граница: что кухня не назначает

Вариативное питание — не ресторан и не два полноценных меню. Это управляемая система: безопасность в приоритете, медицинскую рамку задаёт врач, внутри рамки человеку дают понятный выбор, выбор документируется. Кухня исполняет назначение, но не ставит диагноз.

Граница (произносится раньше списка возможностей). *Без врача:* любые ограничения рациона (включая «диабетический стол»), изменение текстур, протокол при дисфагии и свободной воде, действия при длительном отказе, режим при седации, энтеральное/зондовое и комфортное кормление, сдвиг времени еды у инсулинозависимых. *Без учредителя:* изменение продуктовой строки финансирования, штатного расписания, аутсорсинг, официальный статус пилота. *Без правовой проверки:* формулировки о согласии недееспособного, обработка пищевых карт (152-ФЗ), ответы прокуратуре, конструкции «учреждение = опекун». Таблица «лекарство × еда» на посту законна только с подписью врача.

Как читать числа доклада (четыре класса силы). *Норма* — цитата закона с реквизитами (сильная опора перед проверяющим). *Толкование* — системное прочтение нормы там, где сама норма молчит. *Рекомендация* — «делайте так, потому что так делает конкретное учреждение с публикацией». *Проект локальной формы* — шаблоны в приложениях, требуют правовой проверки. Слово «проверено» без даты и источника — реклама, а не доказательство.

2. Проблема и вопрос

Средний по России ПНИ — около 289 коек (расчёт проекта «Если быть точным», 2024, на данных Федерального казначейства; tochno.st). На обеде — поточная линия с одним вариантом каждого блюда. За человека принимают все решения о еде: при 6-разовом режиме это порядка 2 000 решений в год, ни одно из которых он не выбирал.

Один обед — пять конфликтов: очередь против помощи (самостоятельные едят первыми, кормимые ждут); необнаруженный отказ (журнала нет, врач узнаёт на обходе); лекарства и еда (кофе у жителя на клозапине); добавка без назначения (сиделка отказывает «вам нельзя»); имитация контроля (суточные пробы «задним числом»). Пять «виноватых» — на деле один отказ системы. Вариативность добавит

шестой конфликт — «кто выбирает блюдо»; если пять базовых не закрыты, шестой добьёт систему.

Вопрос доклада: доходит ли право выбора до тарелки — и как сделать, чтобы доходило, не жертвуя безопасностью.

3. Клиническая граница безопасности

Главные риски стола — клинические и измеримые; в докладе они очерчивают, где кончается выбор и начинается назначение.

- **Дисфагия.** В отдельных изученных клинических группах на антипсихотиках распространённость — 21,9–69,5 % (Miarons Font M., Rofes L., Eur J Gastroenterol Hepatol 2017; систематический обзор 18 исследований). **Популяции не совпадают с российскими ДСО; переносить диапазон как рабочую величину нельзя** — свою цифру считают в первые 10 дней пилота по 6 признакам.
- **Смертность.** От пневмонии при шизофрении она в 7 раз выше популяционной (Correll C.U. et al., World Psychiatry 2022; мета-анализ 135 когорт; RR 7,00; 95 % ДИ 6,79–7,23). Аспирация — один из механизмов разрыва продолжительности жизни. Организация стола входит в профилактику преждевременной смертности.
- **Лекарства и еда — четыре правила, которые кухня исполняет по таблице врача:** клозапин↔кофеин, литий↔соль и вода, ИМАО↔тирамин, карбамазепин↔грейпфрут. Одна подписанная таблица на посту; кухня не «убирает кофе сама».
- **Отказ от еды:** три отказа подряд — звонок врачу в тот же день.

Рамка врача сжимает множество блюд — не тарелку до одного блюда.

4. Право РФ: не «запрета нет», а комплект документов

Федеральное право не запрещает вариативность и не обязывает давать выбор каждого блюда. Таблицы замены в раскладках — законный механизм. Директору этого мало: нужна бумага, которая **разрешает практику у него**.

Двойной режим санитарной нормы (норма меняется через 5 дней после сессии): **до 31.08.2026** — СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7.1.11 (≥ 3 приёма в день, диетическое по показаниям); **с 01.09.2026** — СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. ГГСВ РФ от 02.06.2026 № 18, зарег. Минюст № 86854), п. 56 подп. 11 — та же норма дословно (сверено по первоисточнику 22.08.2026), подп. 12–14, п. 62 (питьевой режим), раздел VII. Число вариантов блюда не ограничено ни в одной редакции.

Минимальный комплект документов — то, что превращает практику в систему:

№	Документ	Назначение
1	Положение об организации питания	описывает модель выбора
2	Меню с вариантами	циклограмма с двумя вариантами

№	Документ	Назначение
3	Журнал заказа блюд	документирует выбор
4	Журнал замен	документирует пары эквивалентов
5	Пищевые карты жителей	текстура, ограничения, воля
6	Согласование с учредителем	уведомительный порядок
7	Приказ о рабочей группе	пять фамилий + срок
8	Письмо-уведомление учредителю	одна страница обоснования
9	Таблица врача «лекарство × еда»	на посту, подписана врачом
10	Список риска дисфагии	на посту, подписан врачом
11	Протокол пищевой безопасности	пробы, бракераж, температуры
12	Журнал обучения смены	часы подготовки за 90 дней

Без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки; с комплектом — как управленческое решение. *Класс: норма + проект локальной формы (шаблоны требуют правовой проверки).*

5. Дееспособность и невербальный выбор

В типичном контингенте порядка трёх из четырёх жителей признаны судом недееспособными (74 % — данные проекта «Если быть точным» за 2024 г., публикация 09.04.2026; **не статотчётность Минтруда; в вашем доме цифра будет другой**). При этом до 99 % недееспособных находятся под опекой самого учреждения — это **общероссийская норма, не уникальный риск конкретного дома**.

Сделки совершает опекун (ст. 29 ГК РФ). Но **повседневное предпочтение еды обычно не сделка** — а мнение недееспособного обязаны выяснять и учитывать (ст. 29 ГК, 48-ФЗ). Кто не говорит — того слышат иначе: показ двух порций (выбор глазами), наблюдение за тарелкой, пищевая биография, те, кто знает жителя (персонал, родные, опекун). Замещающее решение «мы знаем лучше» — не стандарт; задача — поддержать волю, а не заменить её «лучшими интересами».

6. Модель без второй кухни

Вариативность — вопрос организации, не бюджета. **Пары эквивалентов:** гречка или рис, курица или индейка — сырьё то же, норматив на продукты не меняется. **Два котла, не вторая кухня:** один поток, две закладки; журнал — тетрадь. Сырьё перераспределяется внутри строки, не добавляется.

Минимальная безопасная модель — шесть опор: документы и журналы в ритме смены; таблица врача и список риска дисфагии на посту (три отказа → врач); на каждого кормимого — конкретный помощник; разбор остатков и хотя бы один канал пожеланий; ночной интервал и отходы известны числом (цель интервала ≤13 ч); пары эквивалентов. Если хоть одна опора не выполняется — начните с неё.

7. Замер вместо декларации

Вариативность без журналов — имитация для проверяющего. Реальность питания проверяется числом, а не лозунгом. Что мерить: доля приёмов с реально доступным выбором (не «% выбравших» — человек вправе не выбирать); доля корректно исполненных заказов; тарелочные и кухонные отходы; отказы и замены; события риска. Формула доступности — $(\text{измеренное} / \text{возможное}) \times 100 \%$. **«Процент выбравших» — не KPI: успех — доступность и исполнение осмысленного выбора.**

8. Наш опыт: что показали замеры (честно)

ДСО «Серафимовский» (СПб; 1 004 проживающих на февраль 2026; 6-разовый режим, ночной интервал 11–12 ч) запустил модель M1 — заказ рациона накануне для части жителей (сообщение Комитета по социальной политике СПб, 22.07.2025; закреплено приказом № 124 от 10.03.2026 в правилах внутреннего распорядка — **локальный акт, не общероссийская норма**).

Что честно: старт был не «без новых денег» — дом прямо назвал, что закупил оборудование и добавил сотрудников, и сам назвал пределы (нормы сбалансированности, здоровье, склонность к популярному нездоровому выбору, «полный переход крайне затруднителен»). Это ценнее победной реляции.

Чего у нас пока нет — числа. Ни один из шести показателей (отказы, отходы, охват скрининга дисфагии, динамика веса/ИМТ, стоимость строки питания до/после, трудозатраты в ставках) **не измерен внутренним замером** и не подставляется оценкой. Это предмет пилота на 90 дней. Первое, что мы измерим, — отходы и отказы: семь дней замера отделяют убеждение от знания.

9. Практики РФ и что применимо из международного опыта

Подтверждено публично (2024–2025): Болотнинский ПНИ и Успенский ПНИ (Новосибирская обл.), Усть-Илимский ДСО и региональная модель Иркутской области, Серафимовский (СПб). Ни один кейс не начинался со «сначала дайте деньги». Важная оговорка: **внедрено публично ≠ доказанный эффект** — панелей «до/после» в открытом доступе почти нет.

Международный опыт — что применимо в РФ и при каких условиях (один абзац; остальное — приложение методички). Ориентиры ночного интервала: Швеция (Livsmedelsverket) ≤11 ч, США (42 CFR §483.60, CMS F-Tag 803) — 14 ч как верхняя граница, не цель; для российского дома рабочая цель ≤13 ч. Поддерживаемое принятие решений (КПИ, ст. 12, Замечание № 1) — ориентир толкования, не прямая обязанность формата «два варианта каши». Зарубежные числа не переносятся на РФ без оговорки о границах переноса.

10. Деньги честно

Мы **не** утверждаем, что вариативность «почти бесплатна». Честная модель начинается с замера: сырьевая строка = расходы на продукты за последний полный месяц ÷ число жителей ÷ число дней. Семидневный замер отходов и трудозатрат до старта — единственный способ получить свою цифру. «Без новой сметы» на одном отделении не значит «без затрат» при полном переходе дома. Закупки: качество не требует повышения норматива — нормативная цена задаёт верхнюю границу расходов, качество (ГОСТ/ТУ, ответственность за несоответствие) — нижнюю границу товара в ТЗ до торгов; экономить на потерях, не на белке.

11. Пилот 90 дней, дорожная карта и ответственность

Пилот реалистичен на одном отделении без новой сметы — три фазы по 30 дней:

Фаза	Дни	Что делается	Чего не делается
1. Замер	1–30	сырьевая строка, отходы, остатки, ночной интервал, 5 чисел контингента, таблица врача	не менять меню, не выбирать модель, не выпускать пресс-релиз
2. Документы	31–60	положение, согласование, пары эквивалентов, обучение, журналы	не масштабировать, не менять закупку
3. Пилот	61–90	запуск выбора, ежедневный сбор данных, контроль на 75-й день	не вводить новые ставки

Отделение 20–35 жителей, лучше «сложное» (группа помощи, неговорящие); одна смена; один приём пищи — обед. Меряют пять групп показателей: заполненность пищевых карт; доля приёмов с доступным выбором (не «% выбравших»); доля корректно исполненных заказов; отходы, отказы и замены; события риска. **Шесть стоп-критериев заданы заранее:** рост пневмоний $\geq 30\%$, падение со смертельным исходом в столовой, жалоба в прокуратуру, приказ учредителя, отзыв согласия учредителя, отсутствие врача.

Пять действий в первый понедельник (до обеда): посчитать сырьевую строку; запустить семидневный замер отходов и времени раздачи; приказ о рабочей группе (пять фамилий, срок 30 дней); письмо-уведомление учредителю (одна страница, ссылка на СанПиН в двойном режиме); выбрать отделение пилота. Через 7 дней на руках — пять готовых предметов, новой сметы не нужно.

Ответственность директора — за систему контроля, а не за каждое событие. Ответственность наступает за неработающий контроль; письмо учредителю о дефиците ресурсов — не индульгенция, но доказательство своевременного реагирования.

12. Пять возражений и заключение

1. «Закон не обязывает — зачем?» — Ответ проверяющему это комплект документов, а не формула «запрета нет».
2. «Клоzapин и кофе — не про нас». — У вас есть жители на антипсихотиках; одна подписанная таблица на посту закрывает тему.
3. «СанПиН меняется, не успеем». — Успеете: п. 56 подп. 11 сохраняет норму дословно; смотрите новую редакцию с 1 сентября.
4. «1000 коек — пилот капля». — Пилот на 20–35 жителях доказывает работоспособность в вашем доме; масштаб — после 90 дней.
5. «Зачем считать “% выбравших”?» — Это не KPI: «нет выбора» — тоже результат, говорящий, что человек удовлетворён стандартом.

Что стоит на чём. По клинике и международным нормам доказательная база плотная; по эффекту вариативности в психиатрии — почти пустая. Поэтому последнее слово руководства — не «внедряйте», а **«измеряйте»**. Право выбора становится реальным тогда, когда его можно проследить до тарелки.

Автор: Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“». Со-модератор сессии 26.08: Нурбаев Т. А., директор СПб ГБУСОН «ДСО „Тесовый берег“». Правовая сверка и фактчекинг — 22.08.2026. Дисклеймер: материал носит информационный и методический характер и не заменяет юридического заключения, клинической рекомендации или финансового расчёта; шаблоны локальных форм требуют адаптации.